

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : جَمَلَاتُ إِبْرَاهِيمَ عَيْسَى خَلِيلٍ

المحافظة : الشرقيه

الحي / المدينة : ابوكبير

العنوان : ~ ~

رقم البطاقة : 26109211300361 رقم التليفون : 01006609916

تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 21-09-1961 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقع:

التوقع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: جمالات ابراهيم عيسى خليا National ID: 26109211300361	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٠/٠٩ ٢٦١.٩٢١١٣.٠٠٣٦١

ر.ب. م.م.م.



انثى مسلمة
ثروت احمد الهادي المناطحي
البيضاة سارية حنن ٢٠٢٧/٠٩/٢١



00
2

جمهورية مصر العربية
بطاقة لتحليل الشخصية



جملات

ابراهيم عيسى خليل
عزبة ابو عليوة - هرايط
مركز ابوكبير - الشرقية

٢٦١.٩٢١١٣.٠٠٣٦١

IN6625936

Patient Name : الأستاذة / د. شيمس فراتيم عيسى خليل	Request No. : 13003932
Patient No. : 26109211300351	Request Date : 10/02/2022
Path No. : 389/2022	Verification Date : 26/02/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام داو السلام - نفقة الدولة
Age : 60 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Post chemotherapy Left breast cancer

Nature of the specimen: WLE + Axillary dissection

Gross Examination:

- Procedure: LT WLE measured 9x4.5x4.5cm with skin covering measured 4.5x1.5cm
- Tumor extent:
 - o Number: One wired greyish white rubbery to firm mass
 - o Size: 1.7x1.5x1cm
 - o Skin involvement: No
- Distance from margins: (Lateral 3cm, medial 2.5cm, superior 0.5cm, inferior 2cm, superficial 1.5cm, deep 2cm)
- Lymph nodes number and size: 18 nodes up to 1.5x1cm
- Frozen section: Free ALL margins

Microscopic examination:

- No residual tumour tissue
- Lymph node involvement: Free (0/18) LNs
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathological complete response
- Additional pathologic findings: One lymph node showed extensive fibrosis and necrosis (therapy effect)

Diagnosis:

Left breast mass: Left WLE + axillary dissection:

- No residual tumour tissue
- Pathological complete response
- Free ALL margins
- Free (0/18) LNs

Verified by

Printing Date : 13/03/2022 09:32:06

Page : of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Name: جملات ابراهيم عيسي خليل		
MR. : 8657		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient presented on 16 March 2026 for a scheduled dose of arimidex and a supplemental treatment plan for a 4-month MRI brain scheduled for 23 December 2025. The MRI was reported as free of acute findings except for involutional brain changes and bilateral small artery disease, and the patient was advised to seek neurological consultation for these findings. On 16 May 2026 the patient received zoledronic acid (Zometa) and calcium supplementation only; the patient reported that she had received the delivery of the medication except for the calcium component. The current status is that the patient is continuing her bisphosphonate therapy with calcium supplementation as prescribed.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Name: Garnier Ibrahim Pasha

Date: 10/07/2007

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

**** Known case of breast cancer.**

1. Chest:

- Left breast lower outer quadrant enhancing mass is seen measuring about 2.5 x 2.2 cm in axial dimensions with related heterogeneous parenchyma. Other few small enhancing nodules are seen at the lower inner quadrant inseparable from the underlying pectoral muscles.
- Enlarged left axillary lymph nodes, the largest measures about 2.8 x 2 cm in axial dimensions.
- Subcentimetric left internal mammary few lymph nodes.
- Left basal solitary pulmonary nodule is seen measuring about 8 mm in diameter.
- Middle lobe, lingular and bilateral basal atelectatic bands.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- Mildly enlarged liver with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Average sized spleen with no focal lesions seen. Adjacent splenule is seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Thickened both suprarenal glands.
- Normal appearance of the pancreas, aorta (apart from atheromatous calcifications), and I.V.C.
- Smooth filling of the urinary bladder with no stones or masses.
- Retroverted uterus with partially calcified lesion, likely fibroid.
- No abdominal or pelvic pathologically enlarged lymph nodes.
- No lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- Left basal solitary pulmonary nodule, for follow up.
- No gross hepatic or osseous metastatic deposits.

Dr. Mohamed Qayati, MSc

Dr. Amr Farouk, MD



NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Gamalat Ebrahim
Referring physician: Prof.

Date: 26/8/2021

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP;

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Degenertative changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are normally seen

Conclusion:

- No definite evidence of metatstatic osseous deposits.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Magdy Koth, M.D.

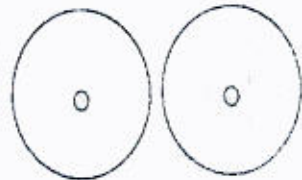


MDT FORM

12/1/2022

Name	جبلت ابراهيم	MRN	C-91/2222
Age	60yrs	ID	571.954.2.371
Menopausal status		Phone	1.9.818.20
OCP		marital status	1
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Ex:	IDC, GII, Initial T2N1			R		L		
ER:	0/8	PR:	5/8	HER 2:		+3	Ki67:	
Sonomammography:								
CAPCT Free, (T2N1) Bonescan								
Mets Workup:								
CAPCT Free Bonescan								

Recommendations:

- The patient received Nivadji ACx4 → Taxol weekly x12 + Herceptin-powder x40 cycles
- It WLE + AC 26/2/2022
- No residual tumor
- LN's 9/18 LNs

MDT OUTCOME & PLAN

- 2/3/2022
- ① For control of ADJ Herceptin for 40 cycles
 - ② Aca dex
 - ③ ADJ FKE

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
		21/5/2022	